Gedanken im Anschluss an die Tagung
Therapeutische Jurisprudenz
„Homo invalidus – oder der wertlose Mensch“
vom 23.3.2006

U. Davatz, www.ganglion.ch

Das Motto der 5. IV-Gesetzesrevision lautet: „Eingliederung vor der Rente“. „Früherfassung und Frühintervention“. Aus der Sicht der Sozialpsychiaterin mit langjähriger Erfahrung in der Rehabilitation von psychisch Kranken kann und muss ich dieses Leitmotiv voll und ganz unterstützen. Die Frage stellt sich nur, wer macht die Früherfassung? Die IV kommt viel zu spät an die Patienten, dann wenn schon vieles schief gelaufen ist. Die KK meldet solche Patienten, die zu chronifizieren drohen nicht der IV, denn zwischen diesen beiden Versicherungen besteht keind regelmässige institutionalisierte Zusammenarbeit. Der Hausarzt ist die Fachperson, welche am frühesten die drohende Invalidisierung wahrnimmt, doch er hat keine Zeit, sich um dieses Problem zu kümmern, er macht was er kann um den Patienten zu heilen und wenn das nicht funktioniert hat, er keine Mittel um die Rehabilitation einzuleiten????? Der Patient ist also sich selbst überlassen, vielleicht konsumiert er noch einen zweiten und einen dritten Arzt, um jedes Mal noch etwas desillusionierter von ihm wegzugehen.
Chronische Leiden haben meistens keine rein medizinischen Ursachen, können deshalb auch nicht auf rein medizinischem Wege gelöst werden. Bei den meisten chronischen Leiden, die schlussendlich zur Invalidisierung führen, spielen schwerwiegende psychosoziale Probleme eine wesentliche Rolle. Aus diesem Grunde sollten bei der so genannten Frühintervention unbedingt diese psychosozialen Faktoren mit einbezogen werden. Der Hausarzt weiss häufig relativ gut Bescheid über diese belastenden psychosozialen Faktoren, kann aber nichts dagegen tun, weil er weder ein Sozialarbeiter noch ein „Casemanager“ zur Verfügung hat. Aus diesem Grunde müsste die IV selbst entweder direkt oder über einen Leistungsauftrag an eine andere Institution, wie z.B. die Lungenliga oder die Pro Infirmis, diese Früherfassung beim Hausarzt in Auftrag geben. Die Hausärzte müssten dahin informiert sein, dass sie eine solche Person, die Abklärungen vornimmt, zuziehen könnten, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Für den Patienten bedeutet dies noch nicht, dass er schon IV-abhängig ist, was ja für ihn meist mit einer grossen Scham verbunden ist, weshalb er die Anmeldung so lange wie möglich hinauszögert und sein Krankheitszustand sich dadurch weiter chronifiziert. Der Patient verhindert also in der Regel selbst seine Früherfassung ganz im

https://adhs.expert

Gegensatz zur verbreiteten Volksmeinung, die Mehrheit der Patienten würde Rentenmissbrauch betreiben.
Die IV-Rente ist bei den meisten Patienten die allerletzte Lösung ihres Problems. Dies hat auch der Chef Berufsberater der IV Aargau, Herr Wehrli ganz klar bestätigt. Die Problematik der steigenden IV-Rentenbezüger darf nicht den Patienten in die Schuhe geschoben werden, IV-Missbrauch sei die Ausnahme und nicht die Regel. Das Problem liegt bei unserem medizinischen Gesundheitsversorgungssystem, das nur teure medizinische Problemlösungen anbieten kann, selbst wenn es sich um psychosoziale Probleme handelt. Dass damit nichts gelöst werden kann, ist klar. Im Weiteren liegt das Problem darin, dass die medizinische Versorgung spezialisiert ist und der Patient nur noch in seinem einzelnen Organ oder Organsystem spezifischen Dysfunktionen behandelt, aber nicht mehr als ganze Einheit, geschweige denn als Teil seines sozialen Systems, sprich Familie und Arbeitsplatz erfasst wird. Somit gehen viele wichtige Daten für einen ganzheitlichen integrativen systemischen Ansatz zur Lösung des gesundheitlichen Problems verloren, ja werden gar nicht erst wahrgenommen, geschweige denn in den Behandlungsplan mit aufgenommen.
Die Frühintervention durch eine von der IV beauftragte Person einer sozialen Institution, wie die Lungenliga oder Pro Infirmis könnte hier als ganzheitlich abklärende Fachperson auftreten und vielleicht einige der unnötigen kostspieligen medizinischen Untersuchungen und Interventionen, die aus reiner ärztlicher Hilflosigkeit dem chronischen Schmerzpatienten gegenüber angeordnet werden, verhindern. Untaugliche Mittel bei einem schwierigen Problem, wie dem chronischen Patienten bringen ausser Kosten nichts, schon gar keine Lösung, dennoch werden sie fleissig weiter von den Aerzten angewandt, weil diese nichts anderes kennen als was sie gelernt haben, eben ihre medizinische Problemlösungen. Auch dies findet sicher nicht aus bösem Willen oder aus Geldgier statt, sondern einzig und allein aus Hilflosigkeit. Auch hier ist der Missbrauch sicher nicht die Regel, sondern nur eine Ausnahme!
Und was soll die Rolle der Juristen sein? Juristen kämpfen auf der Seite der durch das medizinische Netz gefallenen, oder im medizinisch-juristischen Netz gefangenen und dennoch in ihren Bedürfnissen alleine gelassenen Patienten und versuchen für sie Gerechtigkeit zu erlangen, indem Sie eine Rente erwirken, Gerechtigkeit, sprich IV-Rente heilt aber nicht, im Gegenteil, auch wenn die Patienten dann den finanziellen Druck etwas los sind, der psychische Druck invalide, sprich wertlos zu sein in unserer Arbeitsgesellschaf, bleibt weiterhin bestehen. Der Mediziner braucht sich jetzt auch nicht mehr um ihn zu kümmern, er kann ja ohnehin mit seiner Schulmedizin nichts ausrichten, steht ihm als hilfloser Helfer gegenüber, was keine angenehme Rolle ist für einen professionellen Helfer. Der Patient selbst ist längst müde zu kämpfen, er fristet ein

https://adhs.expert

demütigendes Leben mit einer Rente, die weder zum Leben noch zum Sterben genügt. Deshalb muss jeder fast routinemässig noch die Ergänzungsleistung oder gar eine Hilflosenentschädigung anfordern. Aus dieser Position heraus unternimmt er keine grossen Schritte mehr, die zu einer Veränderung führen könnten.
Vielleicht könnte der Anwalt hier noch eine weitere Rolle als Kämpfer der „Casemanager" übernehmen. Er könnte z.B. dem Patienten helfen, eine geeignete sinnvolle Beschäftigung zu suchen. Auch wenn er nicht Sozialarbeiter ist, so hat er vielleicht doch ein grosses soziales Netzwerk zur Verfügung, innerhalb dessen sich vielleicht eine Nische für den Patienten finden liesse, innerhalb von welcher sich dieser im geschützten Rahmen doch noch etwas weiter entwickeln könnte um auf diese Weise wieder etwas Selbstwert zurück zu gewinnen, indem er sich innerhalb einer tätigen Gemeinschaft aufhalten darf, um nicht im Wirtshaus zum Alkoholiker zu werden oder bei den ewig jammernden Sozialbezügern herum hängen muss, fühlt er sich mit Sicherheit integrierter und somit wertvoller.

Die Politiker und die Medien haben die Tendenz Situationen ins Negative zu verzerren und aufzublasen, zu ihrer eigenen Propaganda und Medienwirksamkeit. Die Ausnahme wird zur Regel gemacht, alle Patienten werden als unberechtigte „Rentenbegehrer" angesehen und alle Hausärzte als Betrüger, indem sie ungerechtfertigte Arbeitsunfähigkeitszeugnisse oder Gefälligkeitsgutachten ausstellen.
Dies ist eine absolut unrealistische negative Verzerrung der Sachlage. Aus diesem Feindbild, sowohl dem Patienten als auch den Hausärzten gegenüber (RAD) um diesen Missbräuchen quasi prophylaktisch vorzubeugen. All diese aus Angst vor Missbrauch getroffenen Massnahmen kosten viel Geld, lösen eine riesige Bürokratie aus, aber das ursächliche Problem des ausgegliederten, sich wertlos fühlenden Menschen, nicht.
Die Schlussfolgerung aus unserer Tagung ist viel mehr, dass wir im Vorfeld der Ausgliederung eines Menschen schneller aktiv werden und möglichst unkonventionell freiwillig Zusammenarbeiten müssen unter den verschiedenen Disziplinen. Vielleicht kommen wir dadurch auf schnellere und bessere Problemlösungen bevor es zu spät ist, sich beim Patienten schon alles chronifiziert und die verschiedenen Parteien sich für unendlich viel Geld unlösbar zerstritten haben.

https://adhs.expert